

ANESTESIA EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL. CONTROL DE HEMORRAGIAS POST-EXTRACCIÓN

Pedro Martínez Seijas, Jorge Arenaz Búa, Antonio Cuesta Ramos.

INTRODUCCIÓN

El área Oral, Maxilofacial y Cervical para el tratamiento de heridas y laceraciones Los tipos de anestesia que se pueden utilizar son: **tópica, local infiltrativa, bloqueo de campo, regional o troncular y regional complementada** con sedación oral o endovenosa.

Las cuatro primeras son las de uso habitual en urgencias.

La anestesia regional en el área oral y maxilofacial, es mal llamada como “anestesia local”, o debemos diferenciar la anestesia local infiltrativa del bloqueo de campo y de la anestesia regional, pues los riesgos y efectos secundarios como complicaciones de cada una son distintos.

Los anestésicos locales más usados son: **Lidocaína** (con y sin adrenalina) y **Articaína** con adrenalina. Jeringa de inyección **anestésica tipo carpule** con sistema de aspiración (cartuchos de inyección anestésicos de 1,8 ml).

Técnica de re encapuchado de el agua sin sujetar el capuchón y prevenir pinchazos accidentales: dejar la capucha de la aguja encima de la mesa sin sujetar con la mano y con la carpule introducir la aguja en su interior, cuando esta este dentro tomar la capucha y terminar el proceso.

Hay algunas de un solo uso con sistema de protección de agujas que son útiles para servicios de urgencias para prevenir lesiones por pinchazos en los sanitarios.

- Siempre antes de realizar la inyección debemos aspirar para prevenir y evitar una inyección anestésica intravascular.

El control de las hemorragias post-extracción lo dividiremos en paciente sano y en paciente con riesgo hemorrágico aumentado.

Anatomía aplicada

La Inervación sensitiva de la región oral y maxilofacial va por el **nervio trigémino o V par craneal**. Tiene tres ramas. Primera rama u oftálmica (V1), segunda rama o maxilar (V2) y tercera rama o mandibular (V3).

La inervación sensitiva del cuello lo realiza el plexo cervical superficial que hace su emergencia en el borde posterior del esternocleidomastoideo (ECM) en su unión del tercio superior y medio, posterior a la vena yugular externa a nivel del punto nervioso cervical (erróneamente denominado punto de Erb) (1). Las ramas dérmicas del plexo son: Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso y nervios

supraclaviculares (anterior, medio y posterior).

Anestesia tópica

Las técnicas son pincelar con una torunda, la pulverización y colocación en el lugar de acción con una gasa o algodón empapado en anestésico. Lidocaína 25 mg y Prilocaína 25 mg EMLA®, Tetracaína. Se utiliza en la mucosa para disminuir el dolor y servir de placebo al acto de la inyección.

Anestesia local

Consiste en colocar la anestesia en una zona puntual (Exéresis de una verruga: anestesia en la base de la misma).

A nivel dental es la que se realiza la infiltración del anestésico en la raíz de un diente para anestesiarlo

Anestesia infiltrativa o bloqueo de campo

La técnica en la piel consiste en circundar con infiltraciones de anestesia la zona a tratar. Técnica romboidal: rombo que delimita la zona a intervenir en que la primera infiltración se realiza en un ángulo formando un habón con el líquido anestésico, se deja actuar unos segundos y se progresa siguiendo un lado del rombo hasta un ángulo contiguo, luego se retrocede con la aguja hasta el lugar de inicio realizando el lado restante de ese ángulo; luego se hace un habón en ángulo contralateral y se procede como antes. Otras técnicas son: la perilesional y la lineal.

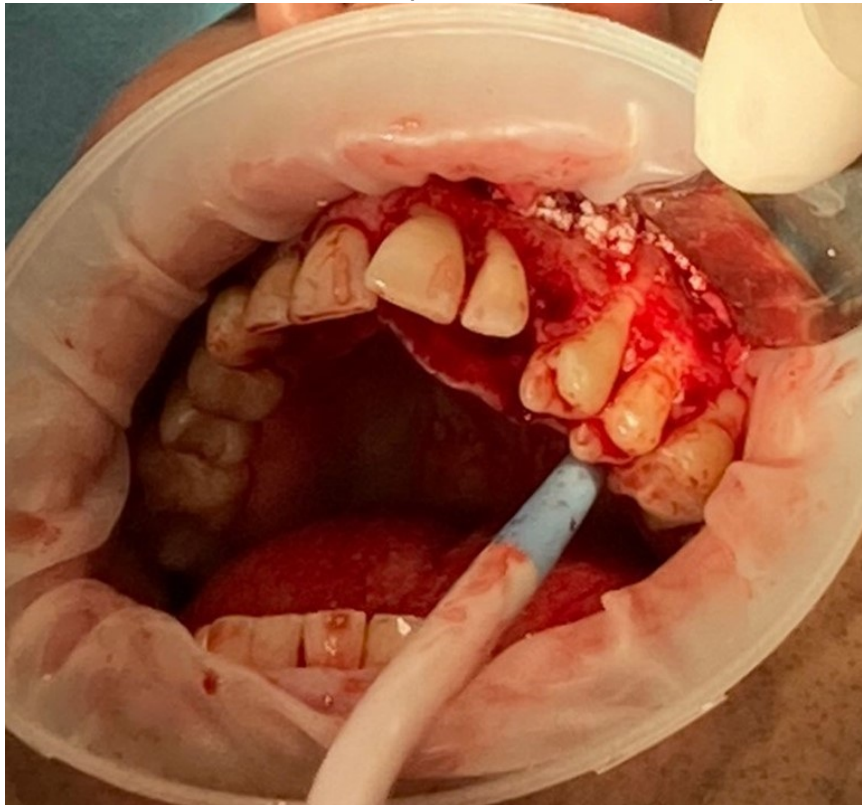
A nivel dental la infiltración en el vestíbulo bucal a nivel de la encía no adherida y en la mucosa palatina, anestesia el diente problema, si queremos mayor extensión se infiltra más a la línea media (mesial) y alejado de la línea media (distal), igualmente en el vestíbulo y en la mucosa palatina.

o Tumefacción

5.- MANEJO DE LAS HEMORRAGIAS POSTEXTRACCIÓN.

Pacientes sin discrasias sanguíneas ni tratamientos antiagregantes o anticoagulantes

Para este procedimiento es preciso contar con un ayudante que separe para trabajar con seguridad con: Buena iluminación. Buena separación. Buena aspiración.



Como primer paso es constatar un sangrado activo, si se constata el mismo es necesaria una buena exploración de la cavidad oral para localizar el origen del sangrado (para ello es necesario contar con una buena iluminación, una buena separación (separador de labios Optagrate®) y una buena aspiración: cánula fina tipo Yankauer).

Cuando hemos localizado el punto o puntos activos de sangrado procedemos a colocar una o varias gasas colocadas en la o las zonas sangrantes y se le dice al paciente que “muerda las gasas y no moverlas”, si son efectivas cabe la opción de mantener la compresión y observar paciente 30 a 40 minutos; si cesa el sangrado seguimos con la compresión.

En caso que se mantenga el sangrado activo se procede al siguiente nivel que consiste en primero preparar lo necesario para el procedimiento (anestesia, campo estéril, hemostático, sutura etc.), luego de anestesiarse la zona y cuando esta abolida la sensibilidad se taponan con un hemostático local esponja de gelatina absorbente, sin comprimirlo en exceso (en este momento se puede realizar un punto simple o en cruz que sujete la mucosa) y comprimir con una gasa o una bola de algodón; otra opción es utilizar un apósito de colágeno.



Pacientes con discrasias sanguíneas ni tratamientos antiagregantes o anticoagulantes

En estos casos lo primero consiste en la corrección de la discrasia y en los segundos revertir la antiagregación o anticoagulación, por parte del servicio de hematología, puesto que cualquier actuación local es secundaria a una actuación general, origen principal del sangrado.

- Un caso especial y de difícil tratamiento hemostático local son las gingivorragias que suelen ser secundarios a problemas periodontales en pacientes anticoagulados, antiagregados o con discrasias sanguíneas y que precisan tratamiento odontológico.
- Actualmente los nuevos anticoagulantes apixaban, dabigatrán son un nuevo reto para el control de las hemorragias en estos pacientes.

BIBLIOGRAFIA

- Tubbs RS, Loukas M, Salter EG, Oakes WJ. Wilhelm Erb and Erb's point. Clinical Anatomy (New York, NY). 2007 Jul 1;20(5):486-8.
- Técnicas de anestesia regional. 2ª Ed. 2001. Panamericana.
- Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. A. López Davis. R. Martín Granizo. Ed. Panamericana. 2012. ISBN: 978-84-9835-271-9.
- Urgencias en Cirugía Oral y Maxilofacial. Juan Andrés Rodríguez Ruíz. 2003. Stratec Medical. ISBN 84-7786-797-6.
- Cirugía Oral y Maxilofacial. 2004. Litofinter. ISBN 84-688-845-0.
- Sugery of the mouth and jaws. 1986. ISBN 0-632-00736-2.